Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5010121-56.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: JURIDES WEILER

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos e examinados os autos.

JURIDES WEILER, ajuizou a *ação ordinária de obrigação de fazer* em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL,** ambas as partes qualificadas na inicial (evento 1, INIC1). Narrou que se encontra em tratamento de Adenocarcinoma de Sigmoide (CID C 18.9), desde 2017, com metástases pulmonares. Ainda, disse que submeteu-se a vários tratamentos quimioteráticos como Folfox e Bevacizumabe, sendo necessária a realização de tratamento com medicação quimioterápica REGORAFENIBE (Stivarga), 160mg ao dia, para utilização de 06 meses ou até progressão da doença. Mencionou ter solicitado administrativamente o procedimento cirúrgico ao plano de saúde réu, mas lhe foi negado. Aduziu a urgência na realização do tratamento, possibilitando a restauração da sua dignidade e integridade física. Referiu que não possui condições financeiras para custear o tratamento. Discorreu sobre a cobertura do plano de saúde e sobre a ocorrência de danos morais. Pleiteou pela concessão de tutela de urgência para determinar que o réu forneça os medicamentos REGORAFENIBE (Stivarga), 160 mg ao dia, por tempo indeterminado. Requereu a procedência da ação. Vindicou a concessão da gratuidade judiciária. Anexou documentos.

Pagas as custas iniciais, recebida a petição inicial, foi requisitado laudo complementar do departamento médico judicial pelo E-NATJUS/RS (evento 5, DESPADEC1).

Sobreveio nota técnica do Departametno Médico Judiciário (evento 13, NOTATEC1) com parecer não favorável a concessão do medicamento. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência (evento 15, DESPADEC1).

Interposto agravo de instrumento pelo parte autora, reformada a decisão do evento 15, DESPADEC1, deferindo a concessão da tutela de urgência (processo 5096794-85.2023.8.21.7000/TJRS, evento 7, DOC1).

Citado, o **Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul-Ipê Saúde** apresentou contestação (evento 27, CONT1), sustentando que possui um protocolo oncológico elaborado pela Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, o qual prevê quais medidas devem ser utilizadas em cada neoplasia. Mencionou que é entidade à qual compete a prestação de serviços de saúde aos funcionários públicos estaduais, não pode admitir nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento. Referiu que a aquisição e a entrega de medicamentos desprovidos de evidências científicas de segurança e eficácia infringe não apenas os arts. 19-0, parágrafo único e 19-Q, § 2º, I da Lei nº 8.080/90, mas também o princípio constitucional da eficiência da Administração. Aduziu que e é um plano de natureza pública, adstrito à regulamentação administrativa, não se lhe aplicando a legislação referente aos direitos do consumidor ou dos demais planos de saúde. Requereu a improcedência do pedido, bem como a isenção do pagamento de custas.

Houve réplica (evento 40, RÉPLICA1).

Intimadas acerca das provas que pretendiam produzir (evento 44, DESPADEC1), as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (evento 48, PET1 e evento 49, PET1).

O Ministério Público apresentou parecer final, opinando pela procedência do pedido (evento 54, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JURIDES WEILER em face do IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando a condenação do réu ao fornecimento do medicamento REGORAFENIBE (Stivarga), 160 mg ao dia, por tempo indeterminado.

A parte autora afirma na petição inicial ser portadora da patologia denominada Adenocarcinoma de Sigmoide, patologia sob CID C 18.9, apresentando progressão da doença, com metástases pulmonares, hepática e peritoneal, sendo necessária a realização do tratamento com os medicamentos REGORAFENIBE (Stivarga), 160 mg ao dia. Sustentou que ter solictado ao réu a concessão, mas foi indeferido na via administrativa.

O IPE-SAÚDE arguiu que o tratamento postulado não se encontra coberto pelo plano.

Inicialmente, cabe salientar que o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPÊ-Saúde, refere que integram o plano de saúde atendimento médico, hospitalar, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde: *(...) Artigo 4º- O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. (...)*

Todavia, o parágrafo único do artigo 4º da citada Lei Complementar restringe o fornecimento de tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais aos que estejam previsto nas tabelas do Instituto.

Insta frisar que, malgrado exista a previsão de exclusão na legislação de regência, somente justifica-se sua incidência quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

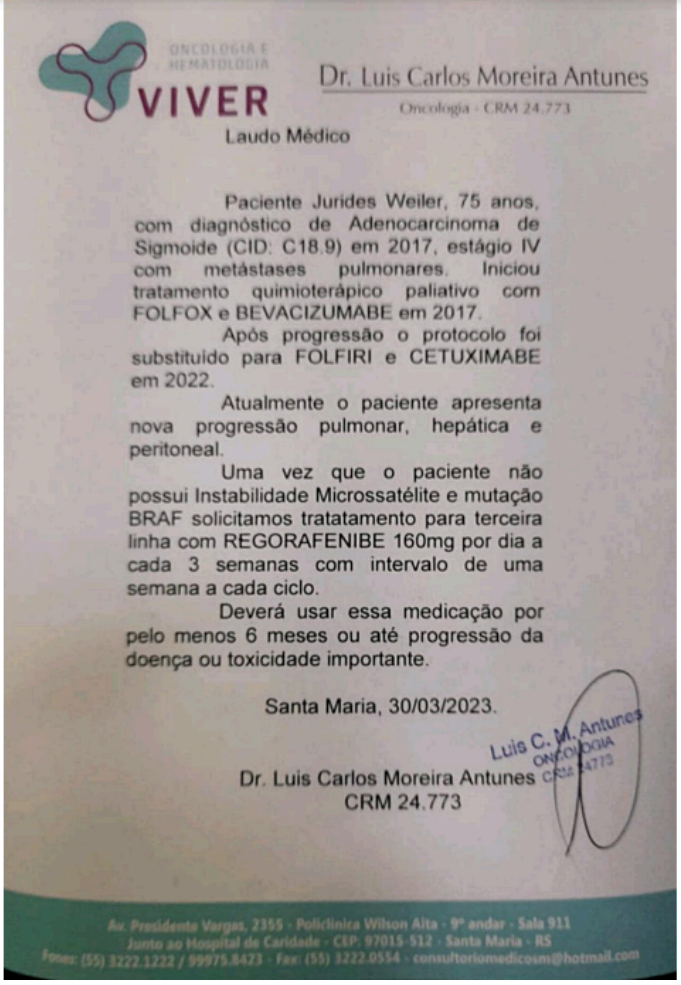
> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ- **SAÚDE**. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO** PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. **A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.** Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo **Oncológico** não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do **medicamento** solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"APELAÇÃO CÍVEL. IPÊ-SAÚDE. LINFOMA NÃO-HODGKIN. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO**. IBRUTINIBE. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. **I. A Lei nº 12.134/2004, que reestruturou o IPERGS, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários (arts. 1º e 2º). II. Em que pese a edição da Lei Complementar nº 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão nos protocolos ou listas da autarquia previdenciária e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia**. III. Honorários advocatícios reduzidos. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080627953, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/03/2019)"[grifo nosso]*

Ademais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento de que não cabe ao plano de saúde selecionar o tratamento que será dispensado ao segurado para a patologia coberta pelo plano, como ilustram as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Tribunal da Cidadania:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.** 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE **SAÚDE**. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo**. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

Dessa forma, extrai-se dever do IPE-SAÚDE em fornecer o tratamento postulado pela parte autora mesmo que este não esteja coberto pelo plano, desde que comprovada sua necessidade.

Na hipótese dos autos, a autora acostou laudo médico (evento 1, LAUDO7) que comprova sofrer da patologia denominada deAdenocarcinoma de Sigmoide, patologia sob CID C 18.9, apresentando progressão da doença, com metástases pulmonares, sendo necessário tratamento com o uso do medicamento REGORAFENIBE, 160mg por dia a cada 3 semanas com intervalo de uma semana a cada ciclo:



ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
VIVER

Dr. Luis Carlos Moreira Antunes
Oncologia - CRM 24.773

Laudo Médico

Paciente Jurides Weiler, 75 anos, com diagnóstico de Adenocarcinoma de Sigmoide (CID: C18.9) em 2017, estágio IV com metástases pulmonares. Iniciou tratamento quimioterápico paliativo com FOLFOX e BEVACIZUMABE em 2017.

Após progressão o protocolo foi substituído para FOLFIRI e CETUXIMABE em 2022.

Atualmente o paciente apresenta nova progressão pulmonar, hepática e peritoneal.

Uma vez que o paciente não possui Instabilidade Microssatélite e mutação BRAF solicitamos tratatamento para terceira linha com REGORAFENIBE 160mg por dia a cada 3 semanas com intervalo de uma semana a cada ciclo.

Deverá usar essa medicação por pelo menos 6 meses ou até progressão da doença ou toxicidade importante.

Santa Maria, 30/03/2023.

Luis C. M. Antunes ONCOLOGIA CRM 24773

Dr. Luis Carlos Moreira Antunes
CRM 24.773

Av. Presidente Vargas, 2355 - Policlínica Wilson Alta - 9º andar - Sala 911
Junto ao Hospital de Caridade - CEP: 97015-512 - Santa Maria - RS
Fones: (55) 3222.1222 / 99975.8423 - Fax: (55) 3222.0554 - consultoriomedicoum@hotmail.com

Portanto, diante do laudo médico juntado pela autora aliado às informações expostas nos eventos 1.8, 1.9 e 1.6, resta demonstrada a necessidade da autora em realizar o tratamento indicado na inicial.

Registro que a condição da autora como segurada do plano de saúde réu foi demonstrada pelo documento do evento 1, OUT6.

Consigno que mesmo demonstrada a necessidade do tratamento pela parte autora, restou indeferido pelo plano de saúde réu.

No entanto, como já exposto, embora não previsto *"nas recomendações técnicas do IPÊ-RS",* tal circunstância não é suficiente para elidir a responsabilidade da Autarquia em fornecer o tratamento adequado para a patologia da demandante.

Em síntese, comprovada a necessidade do tratamento pela parte autora, bem como a responsabilidade em fornecê-lo pela Autarquia ré, impõe-se a procedência do pedido vertido na peça vestibular.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por JURIDES WEILER em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE** para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida em sede de agravo de intrumento no processo 5096794-85.2023.8.21.7000/TJRS, evento 26, DOC2, tornando-a definitiva e condenar a parte ré a fornecer ao autor o medicamento REGORAFENIBE (Stivarga), 160 mg ao dia, por tempo indeterminado.

Isento o IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL ao pagamento das custas.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 600,00, nos termos do §8° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve ser submetida ao reexame necessário, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Colendo Tribunal de Justiça para reexame.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO TEIXEIRA DELABARY, Juiz de Direito**, em 29/01/2025, às 17:37:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073512248v15** e o código CRC **cbbb8fbc**.